

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師	病院薬剤師
☐ nadir期に合わせた電話フォロー(発熱・感染徴候) ☐ 手持ちの抗菌薬の服用開始条件と連絡方法の説明 ☐ G-CSF後の骨痛への対応(体温を測ってから鎮痛薬) ☐ ST合剤・抗ウイルス薬など予防投与の継続確認 ☐ 発熱・受診の経緯をトレーシングレポートで病院へ	☐ レジメンのFNリスク評価とG-CSF一次予防の設定 ☐ 投与前の血液検査で投与可否・減量を判断 ☐ FN発症時の抗菌薬選択と院内対応 ☐ 手持ちの抗菌薬の処方設計と説明 ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載
病院と共有する情報	レジメン・投与日
血液検査値	発熱・感染の有無
予防投与の服用状況	

2 FNのリスク評価とG-CSF・抗菌薬の使い方

状況	対応の基本	薬剤師の確認ポイント
FN発症率20%以上のレジメン	G-CSFの一次予防を推奨	ペグフィルグラスチムは化学療法終了の翌日以降に投与(同日は避ける)
FN発症率10～20%のレジメン	リスク因子(65歳以上・全身状態不良・FNの既往等)で判断	リスク因子を薬歴に記録し、処方医と共有
前コースでFNを起こした	二次予防(G-CSF)または減量・延期	前回の発熱・入院の経緯を薬歴に記録
FN発症時:低リスク(MASCCスコア21点以上)	外来で経口抗菌薬(例:レボフロキサシン+アモキシシリン・クララン酸)	手持ちの抗菌薬の服用開始の条件と連絡方法を説明
FN発症時:高リスク	入院のうえ広域の静注抗菌薬(例:セフェピム等)	至急の受診を勧める

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書 併用注意	メトトレキサート 葉酸代謝阻害の重複・排泄遅延	処方薬 ST合剤	骨髄抑制↑	他院のST合剤の処方を確認
注意 添付文書 併用注意	パルボシクリブ等 CYP3A4阻害	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系抗真菌薬	血中濃度↑ → 好中球減少↑	他院の抗菌薬・抗真菌薬を確認
注意 添付文書 用法・用量	FTD/TPI 空腹時は吸収が増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝夕の食後に服用するよう指導
注意 添付文書 用法・用量	レナリドミド 腎排泄の低下	既往・疾患 腎機能の低下	血中濃度↑ → 骨髄抑制↑	CCrに応じた用量が確認
注意 添付文書 併用注意	レボフロキサシン(手持ちの抗菌薬) キレート形成	処方薬 市販薬 Mg・Al含有の制酸剤・鉄剤	吸収↓ → 効果減弱	服用時間をずらすよう指導
確認 服薬指導上の注意	化学療法中の・患者 発熱を隠す	市販薬 市販の解熱鎮痛薬・かぜ薬	FNの発見の遅れ	服用前に体温を測り、発熱時は連絡

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前 「治療後1～2週は、体を守る白血球が最も減る時期です。体温を毎日測る習慣をつけましょう」 確認: お薬手帳でレジメン・投与日、G-CSFの予定、手持ちの抗菌薬の有無 △ 夜間・休日の連絡先を事前に共有	投与後～1週 「生ものを控え、手洗い・うがいを。ペグフィルグラスチムの後は骨や腰が痛むことがあります」 確認: G-CSF後の骨痛と鎮痛薬の使い方、感染予防の実践 △ 痛み止めを飲む前に体温を測る習慣を	投与後1～2週 「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください」 確認: 電話フォローで発熱・悪寒・のどの痛み・排尿時痛を確認 △ 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診	次回来局時 「前回の治療のあと、熱や出血、息切れはありませんでしたか」 確認: 検査値の推移、発熱・出血・貧血の症状 △ FNや減量の経緯はトレーシングレポートで共有
---	--	--	--